Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
1ª Vara Judicial da Comarca de Eldorado do Sul

Avenida Emancipação, 200 - Bairro: Centro - CEP: 92990000 - Fone: (51) 3098-5393 - Email: freldorasul1vjud@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5001738-97.2022.8.21.0165/RS

AUTOR: HERCULES MUZARANHA
RÉU: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
RÉU: MUNICÍPIO DE ELDORADO DO SUL

SENTENÇA

Vistos.

Hercules Muzaranha ajuizou a presente ação para fornecimento de tratamento de saúde em face do **Município de Eldorado do Sul** e do **Estado do Rio Grande do Sul**. Narrou ser portador de Hiperplasia da próstata (CID 10 N40), motivo pelo qual necessita fazer uso das substâncias "Solifenacina (Impere/Vesicare) 5mg", na quantidade de 30 comprimidos ao mês e "Dulaterida 0,5mg + Tansulosina 0,4mg (Combodart/Dutam)", na quantidade de 30 comprimidos ao mês, por tempo indeterminado. Destacou que referida medicação não integra a lista de medicamentos dispensados pelo SUS e não possui condições financeiras de arcar com o alto custo. Requereu a concessão da gratuidade da justiça e, liminarmente, fosse disponibilizada a medicação de que necessita. Postulou a procedência do pedido com a confirmação da liminar deferida. Juntou documentos (Evento 1, INIC1)

Deferida a gratuidade da justiça e o pedido liminar. Determinada a inclusão da União no polo passivo e a remessa do feito à Justiça Federal (Evento 1, INIC1).

Declarada a incompetência da Justiça Federal para processar o feito (Evento 3, OUT1).

O Estado do Rio Grande do Sul apresentou contestação. Alegou que a tese fixada no tema 793 do STF que determina a observância da questão da repartição de competências no âmbito do SUS, não pode ser ignorada pelo julgador. Requereu a declinação da competência para a Justiça Federal. Postulou a improcedência do pedido inicial, subsidiariamente a observância da denominação comum brasileira (Evento 26, CONT1).

O Município de Eldorado do Sul apresentou contestação. Alegou a sua incompetência frente ao que dispõem as leis infraconstitucionais, sendo atribuição do Estado a concessão dos medicamentos postulados. Requereu a improcedência do pedido (Evento 26, CONT1).

Houve réplica (Evento 31, RÉPLICA1).

Afastadas as preliminares de incompetência (Evento 33, DESPADEC1).

O Ministério Público se manifestou pela procedência do pedido (Evento 45, PROMOÇÃO1).

Vieram os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Decido.

O pedido inicial comporta julgamento antecipado, na forma do art. 355, inc. I, do CPC, porquanto a prova documental produzida nos autos é suficiente ao desate da controvérsia.

Trata-se de ação ajuizada por Hercules Muzaranha em face do Estado do Rio Grande do Sul e do Município de Eldorado do Sul, cujo objeto é o fornecimento das substâncias "Solifenacina (Impere/Vesicare) 5mg", na quantidade de 30 comprimidos ao mês e "Dulaterida 0,5mg + Tansulosina 0,4mg (Combodart/Dutam)", na quantidade de 30 comprimidos ao mês,

A pretensão encontra respaldo no ordenamento jurídico vigente. Com efeito, a Constituição Federal, em seu art. 6º, estabelece que “são direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição”. Em seu art. 23, inc. II, atribui a todos os entes federativos a competência comum para concretizar tal direito.

No art. 196 da CF, consta ainda que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Para regulamentar os dispositivos transcritos, foi publicada a Lei n. 8.080/90, que dispõe sobre as condições para promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes. Consta, no art. 4º da referida lei, que “o conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, constitui o Sistema Único de Saúde (SUS)”.

Já no art. 6º do mesmo diploma legal extrai-se que "estão incluídas ainda no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS): I – a execução de ações: […] d) de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica; […]".

À luz de tais regras, forçoso concluir que a saúde constitui direito fundamental assegurado pelo ordenamento jurídico vigente, cabendo ao Poder Público a execução de ações tendentes à sua efetivação. Nesse contexto, não se justifica a inércia dos entes federados, ante a primazia desse que é considerado um "superdireito de matriz constitucional, que prevalece sobre os princípios orçamentários e financeiros esgrimidos na defesa pelo ente público" (AC 70035231513). Compete, pois, ao administrador público adotar as medidas necessárias para desincumbir-se do mister que lhe foi atribuído pelo constituinte e pelo legislador ordinário.

A realização do direito social à saúde, mediante o fornecimento, pelos entes públicos, de assistência médica e farmacológica, encontra respaldo não apenas na jurisprudência, mas também na doutrina, sendo reconhecida a autoaplicabilidade da norma constitucional que o assegura, bem como seu caráter prestacional, a gerar direito subjetivo aos beneficiários da norma.

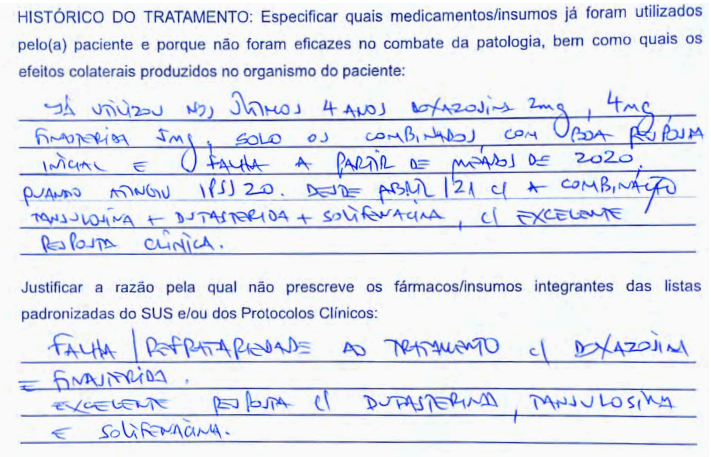
É o que se depreende do magistério de Ingo Wolfgang [1]Sarlet:

> *Em que pese a inequívoca relevância das posições jurídico-fundamentais, é no âmbito do direito à saúde, igualmente integrante do sistema de proteção da seguridade social (juntamente com a previdência e a assistência social), que se manifesta de forma mais contundente a vinculação do seu objeto (prestações materiais na esfera da assistência médica, hospitalar, etc.), com o direito à vida e ao princípio da dignidade da pessoa humana. […] Para além da vinculação com o direito à vida, o direito à saúde (aqui considerado num sentido amplo) encontra-se umbilicalmente atrelado à proteção da integridade física (corporal e psicológica) do ser humano, igualmente posições jurídicas de fundamentalidade indiscutível.*
>
> *[…]*
>
> *Por mais que os poderes públicos, como destinatários precípuos de um direito à saúde, venham a opor – além da já clássica alegação de que o direito à saúde (a exemplo dos direitos sociais prestacionais em geral) foi positivado como norma de eficácia limitada – os habituais argumentos da ausência de recursos e da incompetência dos órgãos judiciários para decidirem sobre a alocação e destinação de recursos públicos, não nos parece que esta solução possa prevalecer, ainda mais nas hipóteses em que está em jogo a preservação do bem maior da vida humana. […] O que se pretende realçar, por ora, é que, principalmente no caso do direito à saúde, o reconhecimento de um direito originário a prestações, no sentido de um direito subjetivo individual a prestações materiais (ainda que limitadas ao estritamente necessário para a proteção da vida humana), diretamente deduzido da Constituição, constitui exigência inarredável de qualquer Estado (social ou não) que inclua nos seus valores essenciais a humanidade e a justiça.*

Em exame da matéria, o Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que mesmo os medicamentos não constantes nas listagens de dispensação do Sistema Único de Saúde devem ser fornecidos pelos entes públicos, se verificado o preenchimento dos seguintes requisitos: "(i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento" (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018).

No caso dos autos, estão atendidos os requisitos necessários para o deferimento do pedido.

Logrou a parte autora comprovar ser portadora de Hiperplasia da próstata (CID 10 N40), conforme o laudo médico juntado com a inicial, que também comprova a necessidade de uso da medicação postulada e a impossibilidade de substituição por outros fármacos disponíveis no SUS, veja-se:


HISTÓRICO DO TRATAMENTO: Especificar quais medicamentos/insumos já foram utilizados pelo(a) paciente e porque não foram eficazes no combate da patologia, bem como quais os efeitos colaterais produzidos no organismo do paciente:

JÁ UTILIZOU NOS ÚLTIMOS 4 ANOS DOXAZOSINA 2mg, 4mg FINASTERIDA 5mg, SOLO OU COMBINADOS COM BOA RESPOSTA INICIAL E FALHA A PARTIR DE MARÇO DE 2020. QUANDO ATINGIU IPSS 20. DESDE ABRIL/21 C/ A COMBINAÇÃO TAMSULOSINA + DUTASTERIDA + SOLIFENACINA, C/ EXCELENTE RESPOSTA CLÍNICA.

Justificar a razão pela qual não prescreve os fármacos/insumos integrantes das listas padronizadas do SUS e/ou dos Protocolos Clínicos:

FALHA/REFRATARIEDADE AO TRATAMENTO C/ DOXAZOSINA E FINASTERIDA.
EXCELENTE RESPOSTA C/ DUTASTERIDA, TAMSULOSINA E SOLIFENACINA.

De igual modo, comprovado que a unidade familiar não possui condições econômico-financeiras para suportar o custo da medicação, pois a renda familiar é oriunda de benefício previdenciário no valor de um salário-mínimo.

Outrossim, deverá ser apresentada prescrição médica atualizada a cada semestre, pois, visto que se trata de medicamento de uso contínuo, deve cingir-se a obrigatoriedade do fornecimento ao período em que demonstrada a necessidade de sua administração à parte autora.

Em conclusão, a procedência dos pedidos é a medida que se impõe.

Isto posto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, julgo procedente o pedido formulado por Hercules Muzaranha em face ao Estado do Rio Grande do Sul e do Município de Eldorado do Sul, para tornar definitivos os efeitos da tutela antecipatória deferida e determinar que o demandados forneçam, de forma gratuita, contínua e ininterrupta, as substâncias "Solifenacina 5mg", na quantidade de 30 comprimidos ao mês e "Dulaterida 0,5mg + Tansulosina 0,4mg", na quantidade de 30 comprimidos ao mês pelo tempo necessário ao tratamento da parte autora, mediante apresentação semestral de prescrição médica atualizada, ou, ainda, o equivalente mensal em dinheiro, observado o preço de mercado, sob pena de bloqueio nas contas públicas.

Condeno o Município de Eldorado do Sul e o Estado do Rio Grande do Sul ao pagamento das despesas processuais (exceto, quanto ao Estado, à condução dos oficiais de justiça). Os entes públicos estão isentos do recolhimento das custas, conforme ADI 70038755864 e o art. 141, §2º, do ECA.

Condeno o Município de Eldorado do Sul, outrossim, ao pagamento de honorários no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) em favor da FADEP, observado o disposto no art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC.

Sentença publicada eletronicamente.

Agendada intimação das partes.

Opostos embargos de declaração, intime-se a parte contrária para contraditório, nos termos do art. 1.023, § 2º, do CPC. Interposto recurso de apelação, intime-se a parte apelada para apresentar contrarrazões, querendo, no prazo legal. Após remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Nada sendo requerido, arquive-se, com baixa.

Documento assinado eletronicamente por **GISELE BERGOZZA SANTA CATARINA, Juíza de Direito**, em 25/9/2023, às 11:53:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10044578079v12** e o código CRC **0ec634da**.

---

1. SARLET, Ingo Wolfgang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais. PortoAlegre: Livraria do Advogado, 2009, p. 322/325. ↩